

Cours De Résidanat

Sujet : 32

Grossesse extra-utérine

Pr Sassi Boughizane Pr Ag Ons Kaabia Dr Maroua Baazaoui

Questions à choix multiples & Cas Cliniques

Session Aout 2025

Questions à choix multiples

1. La grossesse extra utérine (GEU):

- A. Est l'implantation de la grossesse au niveau de l'endomètre
- B. Est l'implantation de la grossesse en dehors de la cavité utérine
- C. Est une maladie trophoblastique
- D. Est une urgence médicochirurgicale
- E. Est la 2^{ème} cause de mortalité maternelle au premier trimestre

2. La GEU peut-être secondaire à :

- A. Un retard de captation ovocytaire par le pavillon
- B. Un retard d'ovulation
- C. Un retard de migration de l'œuf
- D. Un passage rétrograde de l'œuf dans les trompes après un transfert embryonnaire en cas de PMA
- E. Une hyperoestrogénie

3. Parmi les facteurs de risque suivants, lequel n'est pas incriminé dans le risque de survenue d'une GEU :

- A. Antécédent d'une grossesse extra-utérine
- B. Antécédent d'une pathologie tubaire
- C. La contraception micro progestative
- D. Antécédent d'une infection génitale haute
- E. L'utilisation de préservatif

4. La GEU peut s'implanter au niveau de :

- A. La partie ampullaire de la trompe
- B. La partie isthmique de la trompe
- C. L'ovaire
- D. Poumon
- E. Péritoine

5. Concernant la GEU, quelles sont les bonnes propositions ?

- A. La localisation ampullaire est rare
- B. La localisation tubaire est la plus fréquente
- C. La rupture tubaire est très rare
- D. L'évolution peut se faire vers l'avortement tubo-abdominal
- E. L'involution spontanée est la règle

6. L'évolution d'une GEU peut se faire vers :

- A. La rupture brutale
- B. Un avortement tubo-abdominal
- C. La constitution d'un hématosalpinx
- D. L'involution spontanée
- E. La cancérisation

7. Parmi les signes suivants, lesquels ne font pas partie des signes évocateurs d'une GEU :

- A. Des métrorragies noirâtres
- B. Des douleurs pelviennes unilatérales
- C. Une douleur vive au cul de sac de Douglas au toucher vaginal
- D. Une dyspareunie
- E. Signes sympathiques de grossesse exagérés

8. La triade clinique fortement évocatrice du diagnostic d'une GEU au stade hématosalpinx associe :

- A. Douleurs pelviennes, métrorragies et aménorrhée
- B. Douleurs pelviennes, aménorrhée et signes sympathiques de la grossesse exagérés
- C. Aménorrhée, vomissements et état de choc
- D. Aménorrhée, douleurs pelviennes et épanchement abdominal
- E. Douleurs pelviennes, HCG positive et métrorragies

9. Mme H. consulte pour une aménorrhée de 6 semaines avec apparition récente des douleurs pelviennes. Le diagnostic d'une GEU est suspecté ; l'examen de Mme H. peut objectiver :

- A. Une sensibilité sus-pubienne
- B. Un col congestif de grossesse
- C. La présence de glaire cervicale
- D. Une taille de l'utérus diminuée par rapport au terme de la grossesse au TV
- E. Présence d'une masse latéro-utérine douloureuse du côté des douleurs

10. En cas de GEU, le taux de β HCG :

- A. Double toutes les 48 heures
- B. Elimine le diagnostic si inférieur à 300 mUI/ml
- C. Est directement proportionnel à la gravité de la GEU
- D. Est prédictif de complications si supérieur à 1500 mUI/ml
- E. doit être interprété en fonction des constatations de l'échographie pelvienne

11. Mme A., 34 ans, G1P0A1, cycles réguliers, consulte pour une aménorrhée de 6 semaines associée à des douleurs pelviennes récentes. Quel est le premier examen paraclinique à demander :

- A. Une coélioscopie diagnostique
- B. Une hystéroscopie
- C. Une hystérosonographie
- D. Un scanner pelvien
- E. Une échographie pelvienne

12. Le principal signe échographique indirect d'une GEU est :

- A. Un sac ovulaire extra-utérin avec activité cardiaque
- B. La vacuité utérine
- C. La présence d'un sac gestationnel au niveau cervical
- D. Une formation latéro-utérine hétérogène
- E. L'absence d'un épanchement dans le Douglas

13. Au cours des dix premières semaines de la grossesse, toutes ces étiologies peuvent être à l'origine de métrorragies, sauf une, laquelle :

- A. Une grossesse molaire
- B. Une menace d'avortement spontanée
- C. Une grossesse cervicale
- D. Un avortement en cours
- E. La nécrobiose d'un fibrome utérin

14. Parmi les modalités thérapeutiques d'une GEU, on peut citer ces méthodes sauf :

- A. Une salpingotomie
- B. Une salpingectomie par laprotomie
- C. Une salpingectomie par voie coelioscopique
- D. Une hystéroscopie opératoire
- E. Une injection de methotrexate

15. Le traitement d'une grossesse extra utérine par le méthotrexate demeure possible si :

- A. Présence d'une thrombopénie inférieure à $100.000 /\text{mm}^3$
- B. Présence d'un hémopéritoine de grande abondance à l'échographie pelvienne
- C. Des transaminases hépatiques à 5x la normale
- D. Une image latéro-utérine embryonnée avec activité cardiaque positive
- E. Présence d'un hématosalpinx de 1.5 cm

16. Le traitement chirurgical de la grossesse extra-utérine est indiqué si :

- A. Patiente pauci-symptomatique avec un taux de β HCG à 11.000 mUI/ml
- B. Un hémopéritoine de grande abondance à l'échographie
- C. Grossesse extra-utérine embryonnée
- D. GEU asymptomatique avec un taux de HCG à 80 mUI/ml
- E. Patiente en état de choc

17. Le diagnostic d'une GEU gauche a été retenu chez Mme S. avec une indication à un traitement médical par méthotrexate. Quelles sont les bonnes propositions ?

- A. La dose préconisée est de 1 mg/kg
- B. La voie d'administration la plus utilisée est la voie intra-veineuse
- C. Ce traitement n'a pas d'effets indésirables
- D. Le bilan pré-thérapeutique comporte une échographie hépatique
- E. Un contrôle du taux de la HCG est indiqué à H48

18. La salpingotomie est une chirurgie conservatrice de la trompe qui peut être indiquée en cas de Grossesse extra utérine. Quelles sont les bonnes propositions concernant cette technique ?

- A. Elle consiste à une aspiration de la grossesse par voie hystéroscopique
- B. Elle expose au risque d'échec par rétention trophoblastique
- C. Elle expose au risque de récurrence homolatérale
- D. Elle impose une surveillance post opératoire de la décroissance du taux de la HCG plasmatique
- E. Un traitement adjuvant par méthotrexate est systématique

19. Mme J. a reçu une injection de méthotrexate pour une GEU paucisymptomatique. Quelles sont les modalités de la surveillance biologique ?

- A. Un dosage quantitatif de la HCG à J0 est obligatoire
- B. Le premier dosage quantitatif de la HCG post méthotrexate est indiqué à J2
- C. Le premier dosage qualitatif de la HCG post méthotrexate est indiqué à J4
- D. Le 2ème dosage quantitatif de la HCG post méthotrexate est indiqué à J7
- E. Aucune surveillance biologique n'est indiquée.

20. La salpingectomie dans le cadre de la prise en charge thérapeutique d'une GEU est indiquée si :

- A. Pas de désir de grossesse ultérieure
- B. Hémorragie tubaire incontrôlable
- C. Récurrence homolatérale d'une GEU
- D. GEU embryonnée
- E. Antécédent de plastie tubaire contralatérale à la GEU

21. Parmi les contre-indications du traitement médical de la GEU, on peut citer :

- A. Refus de la patiente
- B. Etat hémodynamique instable
- C. Activité cardiaque visible sur la GEU
- D. Hématosalpinx > 5 cm
- E. Taux d'hémoglobine à 12g/dl

22. Concernant le traitement médical de la GEU :

- A. Le méthotrexate est contre-indiqué chez les patientes présentant un surpoids
- B. Il faut fractionner la dose sur 3 prises
- C. Peut être utilisé en cas de doute sur une grossesse hétérotopique
- D. Peut se compliquer par une neutropénie
- E. Est contre indiqué en cas d'élévation des enzymes hépatiques

Cas Cliniques

Cas clinique 1:

Madame A, 27 ans, G2P2, antécédent d'accouchement par césarienne, consulte pour une aménorrhée de 05 semaines, elle dit qu'elle n'a pas de douleurs pelviennes.

A l'examen :

- ✓TA 12/7, pouls :70 battements/min, abdomen souple
- ✓Spéculum : Métrorragies minimales noirâtres
- ✓Toucher vaginal non douloureux

1.Quels sont les diagnostics possibles ?

- A. Grossesse jeune arrêtée
- B. Grossesse jeune évolutive
- C. Trouble du cycle
- D. Grossesse extra-utérine
- E. Utérus malformé bicorne-bicervical

A l'échographie :

- ✓utérus vide,
- ✓pas de masse latéro-utérine,
- ✓douglas libre

βHCG:1000 mUI/ml

2. Quelle est votre conduite à tenir ?

- A. Revoir la patiente dans 48 heures et réaliser une échographie pelvienne et une βHCG
- B. Revoir la patiente dans une semaine et réaliser une échographie pelvienne et une βHCG
- C. Réaliser une coelioscopie vu le doute diagnostique
- D. La coelioscopie diagnostique est contre indiquée vu l'antécédent d'accouchement par césarienne
- E. L'hospitalisation de la patiente est obligatoire vu le doute diagnostique

Lors du contrôle, la βHCG :980 mUI/ml et l'échographie pelvienne trouve :

- ✓utérus vide,
- ✓apparition d'une image latéro-utérine droite en cocarde de 1.8 cm,
- ✓douglas libre

3. Quel est votre diagnostic ?

- A. Grossesse jeune arrêtée
- B. Grossesse jeune évolutive
- C. Trouble du cycle
- D. Grossesse extra-utérine
- E. Utérus malformé bicorne-bicervical

4. Qu'est-ce que vous proposez à Mme A.?

- A. Abstention thérapeutique
- B. Un traitement médical par méthotrexate
- C. Une aspiration écho guidée
- D. Une coelioscopie diagnostique et opératoire
- E. Une laparotomie

5. La surveillance post thérapeutique comporte :

- A. Une surveillance clinique
- B. Une surveillance échographique
- C. Un dosage quantitatif de la HCG à J2
- D. Une injection de méthotrexate à J4
- E. Un dosage quantitatif de la HCG à J7

Cas clinique 2 :

Madame K, 27 ans, G2P2, antécédent d'accouchement par césarienne compliquée d'endométrite et un accouchement par forceps, contraception par oestroprogestatifs minidosés, consulte pour des douleurs pelviennes.

A l'examen :

✓TA 11/7, pouls :80 battements/min, abdomen souple

✓Spéculum : Métrorragies minimales noirâtres

✓Toucher vaginal non douloureux

A l'échographie pelvienne:

✓utérus vide,

✓masse latéro-utérine de 3,5 cm droite,

✓douglas libre

βHCG:4500 mUI/ml

1. Quels sont les facteurs de risque d'une grossesse extra utérine chez cette patiente?

- A. Age jeune
- B. Contraception par les oestroprogestatifs minidosés
- C. Antécédent de césarienne
- D. Antécédent d'infection génitale haute
- E. Accouchement par forceps

2. Quel est votre conduite à tenir ?

- A. Cœlioscopie en urgence pour une GEU rompue
- B. Traitement Médical
- C. Cœlioscopie pour un doute diagnostique
- D. Revoir la patiente dans 48 heures avec échographie pelvienne et une βHCG
- E. Abstention thérapeutique

3. Votre choix thérapeutique est justifié par :

- A. Une image latéro-utérine de 3,5 cm
- B. Le taux de β HCG
- C. Antécédents d'accouchement par forceps
- D. Etat hémodynamique stable
- E. L'âge de la patiente

4. Le bilan biologique à demander avant d'instaurer ce traitement comporte :

- A. Un bilan hépatique (ASAT/ ALAT)
- B. Une NFS
- C. Un bilan rénal (urée-créat)
- D. Une consultation pré-anesthésique
- E. Une CRP

Cas clinique 3 :

Madame J, 32 ans, ayant des antécédents d'infection génitale haute traitée en ambulatoire, et de grossesse extra utérine traitée chirurgicalement. Elle est tabagique, G2P0A2, sous contraception par un microprogestatif

Elle vous consulte pour un saignement de faible abondance sur une aménorrhée de 6 semaines et 4 jours.

1. Quel est le premier diagnostic à évoquer?

- A. Une infection génitale haute
- B. Une grossesse extra-utérine
- C. Une grossesse molaire
- D. Une fausse couche spontanée
- E. Une menace d'avortement

2. Quels sont les arguments en faveur de ce diagnostic chez cette patiente ?

- A. Antécédent d'infection génitale haute
- B. Antécédent de grossesse extra utérine
- C. Le tabagisme
- D. La nulliparité
- E. La contraception par microprogestatif

L'échographie pelvienne montre un utérus de taille normale, vide.

Un dosage des β HCG est revenu positif à 950 mUI/ml.

3. Quels sont les deux diagnostics les plus probables à ce stade chez cette patiente ?

- A. Une grossesse jeune menacée
- B. Un avortement en cours
- C. Une grossesse molaire
- D. Une grossesse extra utérine
- E. Une infection génitale haute

On propose à la patiente de refaire l'échographie pelvienne et le dosage des β HCG dans 48 heures.
Les mêmes constatations sont retrouvées à l'échographie avec une ascension des HCG à 2658 mu/ml.

4. Quel diagnostic retenez-vous pour cette patiente ?

- A. Une grossesse jeune menacée
- B. Un avortement en cours
- C. Une grossesse molaire
- D. Une grossesse extra utérine
- E. Une infection génitale haute

Vous proposez à la patiente une coelioscopie diagnostique mais qui est refusée par cette dernière.
La patiente reconsulte quelques heures après pour des douleurs pelviennes violentes avec vertiges.
A l'examen : TA : 80/40 mmHg, pouls : 140 bat/mn, avec une défense abdominale généralisée.

5. Quelle serait votre conduite à tenir ?

- A. Une échographie pelvienne de contrôle
- B. Transfert immédiat au bloc opératoire
- C. Une dose de méthotrexate
- D. Un scanner pelvien
- E. Une aspiration écho guidée

Cas clinique n 4 :

Mme N 30 ans, aux cycles réguliers et désirant un enfant, vous consultez pour une aménorrhée de 6 semaines, douleurs pelviennes et métrorragies.

On note dans ses antécédents une plastie tubaire par coelioscopie.

Vous trouverez à l'examen physique des annexes sensibles sans masse perçue.

1. Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu ?

- A. Une endométrite
- B. Une torsion d'un kyste de l'ovaire
- C. Une endométriose pelvienne
- D. Une grossesse extra utérine
- E. Une menace d'avortement spontané

L'échographie révèle:

- ✓une image latéro utérine hétérogène de 3*4 cm
- ✓un épanchement de moyenne abondance dans le Douglas.

Les HCG plasmatiques sont à 250 mUI/ml.

2. Quelle est votre attitude ?

- A. Abstention thérapeutique et contrôle échographique et biologique dans 7 jours
- B. Laparotomie exploratrice d'emblée
- C. Curetage et surveillance clinique
- D. Coelioscopie
- E. Biopsie de l'endomètre et coelioscopie en fonction du résultat

Au terme de votre démarche diagnostique, vous décidez d'une coelioscopie, au cours de laquelle vous découvrez une grossesse extra-utérine droite de 3cm de diamètre, ampullaire rompue avec une trompe de mauvaise qualité ; la trompe contro-latérale est d'aspect normal.

3. Quel est le geste thérapeutique le plus adapté ?

- A. Injection in situ de méthotrexate
- B. Salpingotomie et extraction de l'œuf
- C. Salpingectomie droite
- D. Salpingectomie bilatérale
- E. Salpingectomie droite et ligature tubaire